

TEMA 3.25 • OBSTETRICIA

Eclampsia

PERFIL EUNACOM 2.01.2.019
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Eclampsia

Definición

Preeclampsia + convulsiones o coma.

NOTA CLÍNICA

Puede presentarse sin diagnóstico previo de preeclampsia. Si una embarazada convulsiona sin causa clara → manejar como eclampsia y luego buscar otras causas si no concuerda.
Puede ocurrir **anteparto, intraparto o postparto inmediato**.

Predictores (pródromos de eclampsia = exaltación neurológica)

- Tinnitus
- Fotopsias / fotofobia
- **Hiperreflexia** (reflejos osteotendinosos exaltados)
- Cefalea intensa
- Visión borrosa
- Confusión

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Con **exaltación neurológica** → administrar **sulfato de magnesio** inmediatamente como profilaxis de eclampsia (no esperar convulsiones).

Tratamiento de la Eclampsia

Orden de prioridades:

- **ABC** (estabilizar)
- **Sulfato de magnesio** (controla las convulsiones)
- **Interrumpir el embarazo** (tratamiento definitivo)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

¿Qué es más importante: $MgSO_4$ o la interrupción? La interrupción es el tratamiento definitivo, pero si la pregunta es "¿qué conducta toma primero?", la respuesta es **$MgSO_4$** .

Vía de interrupción: Vaginal (de regla). En la práctica frecuentemente termina en cesárea (sufrimiento fetal, urgencia).

Sulfato de Magnesio — Dosis y Monitorización

Dosis

TABLA 3.25.1: FASE VS DOSIS

FASE	DOSIS
Carga	5 g EV (en goteo lento, no bolo directo)
Mantención	1-2 g/hora EV durante 24h

Indicaciones

- Eclampsia (tratamiento)
- Exaltación neurológica (profilaxis)
- Parto en preeclampsia (profilaxis intraparto)

Monitorización de toxicidad

TABLA 3.25.2: PARÁMETRO VS ALERTA

PARÁMETRO	ALERTA
Reflejos osteotendinosos	Se pierden primero
Frecuencia respiratoria	Disminuye → paro respiratorio
Diuresis	El Mg se excreta por riñón — alto riesgo si hay IRA

Antídoto de toxicidad por $MgSO_4$

Gluconato de calcio 1 g EV en bolo

NOTA CLÍNICA

El gluconato de calcio EV sirve para 3 situaciones: hiperpotasemia, hipocalcemia e **hipermagnesemia** (intoxicación por $MgSO_4$).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 32 semanas de gestación con PA 158/105 mmHg en dos mediciones, proteinuria de 500 mg en orina de 24h y cefalea intensa. ¿Diagnóstico?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Eclampsia. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Definición
- Predictores (pródromos de eclampsia = exaltación neurológica)
- Tratamiento de la Eclampsia
- Sulfato de Magnesio — Dosis y Monitorización
- Indicaciones
- Monitorización de toxicidad
- Antídoto de toxicidad por $MgSO_4$

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ECLAMPSIA)

PREGUNTA 1

Mujer de 32 semanas de gestación con PA 158/105 mmHg en dos mediciones, proteinuria de 500 mg en orina de 24h y cefalea intensa. ¿Diagnóstico?

- ☐ A) Hipertensión gestacional sin proteinuria
- ☐ B) Preeclampsia con criterios de severidad
- ☐ C) Hipertensión crónica agravada
- ☐ D) Eclampsia
- ☐ E) Síndrome de bata blanca — repetir en casa

PREGUNTA 2

¿Cuál es el tratamiento de elección para prevenir las convulsiones (eclampsia) en una paciente con preeclampsia grave?

- ☐ A) Nifedipino oral para bajar la presión
- ☐ B) Sulfato de magnesio IV
- ☐ C) Fenobarbital IM
- ☐ D) Diazepam IV en bolo
- ☐ E) Corticoides para maduración pulmonar fetal

PREGUNTA 3

¿Cuál es el único tratamiento definitivo de la preeclampsia?

- ☐ A) Antihipertensivos de por vida
- ☐ B) Reposo absoluto hasta el término
- ☐ C) Interrupción del embarazo (parto)
- ☐ D) Hemodiálisis para eliminar los factores vasopresores
- ☐ E) Ácido acetilsalicílico a dosis antiagregante

RESUMEN: ECLAMPSIA

:::note Puede presentarse sin diagnóstico previo de preeclampsia. Si una embarazada convulsiona sin causa clara → manejar como eclampsia y luego buscar otras causas si no concuerda. :::warning Con exaltación neurológica → administrar sulfato de magnesio inmediatamente como profilaxis de eclampsia (no esperar convulsiones). ::: 1. ABC (estabilizar) 2. Sulfato de magnesio (controla las convulsiones) 3. Interrumpir el embarazo (tratamiento definitivo)